이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

의 무 기 록 사 본 증 명 서

발행번호 202506590019

등록번호 : 69768374

환 자 명 : 이진희

용 도 : 보험회사제출용

발급매수 : 20 매

첨부한 사본은 의무기록 원본과 틀림이 없음을 증명합니다.

* 본 사본은 상기 용도 외에는 사용할 수 없음 *

2025 년 6 월 24 일

의 료 정 보 관 리 팀

담당자 신윤정

* 담당자의 날인(서명)이 없는 것은 무효임 *

서 울 아 산 병 원 장

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 초진 기록
(Outpatient Initial Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

진료과: 신경외과 진료일자: 2024-10-28

2024-10-28 [신경외과] 외래 나이/성별: 51y/F

주호소(Chief Complaint)

간헐적인 정수리 통증 onset : 1YA

통증 평가(Pain Assessment)

통증 : 무

현병력(Present Illness)

김정훈교수님컴펌됨 김종혁교수님요청건입니다

3-4MA 상기 증상 빈도가 잦아짐
정밀 검사 및 치료위해 본원 내원함

영상 의뢰서 미지참

과거력(Past Medical History)

FHx: (모: 심장질환)
SHx: alcohol(-)smoking(-)
PMH: HTN(-), DM(-), Tbc(-), 갑상선질환/결절(-)HL(-), 턱관절 통증-진료중, 부비동염-진료예정
심장질환,시술여부(-),신장질환(-)튜석(-),호흡기질환/천식/폐쇄성폐질환(늑막염치료력, 30YA)간질환(-)
뇌혈관질환(-)
medication: (리보트릴)

Lab. finding & study

두통, 오심
구토

평가 및 추정 진단(Assessment)

r/o brain tumor ?

치료 계획(Plan)

일단 검사 후 판단
가능한 빨리 mr 후 오시기

2024-10-28 12:58 민유선 2024-10-28 13:40 김정훈

진료과: 가정의학과 진료일자: 2024-10-28

2024-10-28 [가정의학과] 외래 나이/성별: 51y/F

주호소(Chief Complaint)

for workup onset : 0.0

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 초진 기록
(Outpatient Initial Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

통증 평가(Pain Assessment)

통증 : 유
도구 : NRS
부위 : head & neck , other - 간헐적인 정수리 통증
점수 : 8
양상 : 기타 - 무거운 느낌
빈도 : 간헐적

현병력(Present Illness)

타과의뢰위해내원

과거력(Past Medical History)

h/o 부비동염

턱관절 관련 타원에서 진료 받으심

신체 검진(Physical Examination)

외래경과 기록참조

Lab. finding & study

외래경과 기록참조

평가 및 추정 진단(Assessment)

Visit for consultation

치료 계획(Plan)

consult as patient wants

2024-10-28 13:59 김정은 2024-10-28 14:01 김정은

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 경과 기록
(Outpatient Progress Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

진료과: 신경외과 진료일자: 2024-10-30
2024-10-30 [신경외과] 외래 나이/성별: 51y/F

▶#

객관적 소견(Objective)

F/51y; 생년월일:1972-12-05서울특별시 강남구

r/o meningioma, left sphenoid ridge, 51 YO female

우연히 발견
증상과 맞지 않음
크기 작지 않음
나이 아주 많지 않음
언제인가 무조건 치료
치료를 한다면 절제 원칙
감마나이프 방사선수술은불가능 : 크기 큼
절제 원칙 : 절제 꺼리시면 방사선치료 고려할 수 있음
응급 아님
환자 분 가장 한가할 때 절제를 고려하는 것이 옳을 듯 함
위치 불량 : 동맥, 해면정맥동, 3-6번 뇌신경 등등과 매우 복잡한 관계

절제 이후 3번 동안 신경 마비에 의한 안검 하수는 특히 발생할 가능성이 매우 높음!!!!!!!!!!!!

절제 시 동맥 손상을 받으면 매우 심각한 후유증 및 합병증 발생 가능함

응급은 아님
그럼에도 언제인가 절제술이 필요할 것으로 판단됨
타원도 충분히 알아 보시기
가족 분들과도 충분하게 상의해 보시기
일단 cta 후 판단

평가(Assessment)

R/O brain cancer, unspecified site

치료 계획(Plan)

cta 후 오시기

2024-10-30 15:03 김정훈 2024-10-30 15:19 김정훈

진료과: 신경외과 진료일자: 2024-11-20
2024-11-20 [신경외과] 외래 나이/성별: 51y/F

▶#

객관적 소견(Objective)

F/51y; 생년월일:1972-12-05서울특별시 강남구

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 경과 기록
(Outpatient Progress Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

r/o meningioma, left sphenoid ridge, 51 YO female

응급 아님
절제 원칙
응급 아님
환자 분 가장 한가할 때 절제를 고려하는 것이 옳을 듯 함
위치 불량 : 동맥, 해면정맥동, 3-6번 뇌신경 등등과 매우 복잡한 관계
그러나 절제 간단하지 않음
절제 이후 당연히 후유증 및 합병증 발생 가능함
절제 이후 특히 3번 동안 신경 마비에 의한 안검 하수는 특히 발생할 가능성이 매우 높음
절제 시 동맥 손상을 받으면 매우 심각한 후유증 및 합병증 발생 가능함
절제 이후 그 이외 다른 후유증 및 합병증 발생 가능함
응급은 아님
그럼에도 언제인가 절제술이 필요할 것으로 판단됨
타원도 충분히 알아 보시기
가족 분들과도 충분하게 상의해 보시기
본원에서 절제 원하심
응급은 아님
본원에서 절제 원하심
일단 수술 스케줄 잡음
검사 후 최종 결정

평가(Assessment)

R/O meningioma, brain, cerebral meninges

치료 계획(Plan)

4월 1일 수술
그 전에 입원

수술 전 검사
2월 말 경 시행 후 외래 오시기

2024-11-20 09:43 김정훈
진료과: 신경외과 진료일자: 2025-03-17
2025-03-17 [신경외과] 외래 나이/성별: 52y/F

▶#

객관적 소견(Objective)

F/52y; 생년월일:1972-12-05;서울특별시 강남구

r/o meningioma, left sphenoid ridge, 52 YO female

수술 원하시어 수술 스케줄 잡고 수술 전 검사 후 내원하시기로 한 환자
수술 전 검사 상 비교적 건강하심
응급은 아님

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 경과 기록
(Outpatient Progress Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

100% 안전한 수술 절대로 없음
절제 이후 후유증 및 합병증 발생 당연히 가능함
절제술 후 발생 가능한 합병증 및 후유증 :
1) 출혈이 발생할 수 있음 : 만약 출혈이 발생하면 환자 상태 매우 불량해질 수 있으며, 재수술이 필요하며, 뇌부종, 뇌압 상승, 사망, 의식 저하, 사지 마비, 언어 장애, 호흡 곤란, 기타 예상치 못한 상태 등등이 발생할 수 있으며 이로 인해 재수술을 시행할 수 있으며, 장기간의 병상 생활을 해야만 함
2) 동맥 및 정맥 손상이 발생하면 사망의 가능성이 매우 높으며, 재수술, 혈관내 수술(코일 색전술 포함) 필요할 수 있으며, 그리고 동맥 손상이 발생하는 경우 출혈, 경색, 출혈성 경색, 뇌부종, 뇌압 상승, 의식 저하, 사지 마비, 언어 장애, 호흡 곤란, 매우 심각한 후유증 및 합병증을 포함한 기타 전혀 예상치 못한 상태 등등 발생할 수 있으며 이로 인해서 장기간의 병상 생활을 해야만 함 ---> 이러한 경우 사망의 가능성 매우 높음
3) 2번 시신경 손상 발생할 수 있으며 이러한 경우 수술 전보다 오히려 시력 및 시야 장애 심해질 수 있음,그리고 3번 동안 신경 마비 발생할 수 있으며 이러한 경우 안검 하수 및 복시, 눈동자 움직임 이상 발생 가능함. 3번 동안 신경 마비에 의한 안검 하수는 특히 발생할 가능성이 매우 높음!!!!!!!!!!!! 그리고 1번 신경 손상에 의한 후각 장애, 냄새 맡지 못함, 4번 및 6번 신경 손상에 의한 복시 및 눈동자 움직임 이상, 5번 신경 손상에 의한 안면 감각 이상, 안면 이상한 느낌, 안면 통증 등등 발생 가능함
4) 호르몬 이상 : 호르몬 저하증을 포함한 호르몬 이상 발생할 수 있으며 이러한 경우 평생 동안 여명기간동안호르몬을 복용하여야만 하며, 호르몬 이상에 따른 합병증 및 후유증 발생 가능함
5) 종양의 불완전 제거에 따라서 향후 재발, 재수술, 또는 방사선 치료 등등의 다른 치료가 필요함
6) 감염 및 염증, 상처 부위 나쁨, 가성 뇌수막류 (뇌척수액이 세는 것) 등등 발생 가능하며, 이러한 경우 재수술 가능하며, 그리고 장기간의 항생제 사용을 해야만 하며 이러한 경우 항생제가 잘 듣지 않으면 뇌수막염을 포함한 염증, 감염에 의해 사망, 장기간의 병상 생활, 의식 저하, 언어 장애, 기타 예상치 못한 합병증 및 후유증 발생 가능함
7) 기타 예상하지 못한 합병증 및 후유증 (폐 및 심장, 신장, 위, 간 등등) 발생 가능함
8) 수술 부위 이외 뇌의 다른 부위 출혈도 발생 가능함---> 이러한 것들까지 예측할 수 없음
절제 이후 3번 동안 신경 마비에 의한 안검 하수는 특히 발생할 가능성이 매우 높음!!!!!!!!!!!!
절제 시 동맥 및 정맥 손상을 받으면 매우 심각한 후유증 및 합병증 발생 가능함
응급은 아님
그럼에도 절제술이 필요할 것으로 판단됨
향후 수술을 시행하는 경우 상기 기술한 내용은 관련 의료진을 통한 수술동의서 작성 시 환자 및 환자 보호자 분들께 추가로 충분하고 자세히 설명을 드릴 예정임
타원도 충분히 알아 보시기
가족 분들과도 충분하게 상의해 보시기
예정대로 입원하여 예정대로 절제 원하심

평가(Assessment)

R/O meningioma, brain, cerebral meninges

치료 계획(Plan)

예정대로 입원
입원 2일 전 약 복용
수술 전 설명 시 다시 한번 더 자세히 설명 예정
입원 후 수술 전 설명을 들을 때 환자 및 환자와 관계되는 보호자 분이 반드시 오시어 충분하게 설명을 들어야만 함

뇌수막종에 준하여 산정특례 해 드리기

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 경과 기록
(Outpatient Progress Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

2025-03-17 15:37 김정훈

진료과: 신경외과 진료일자: 2025-05-07

2025-05-07 [신경외과] 외래 나이/성별: 52y/F

▶#

객관적 소견(Objective)

F/52y; 생년월일:1972-12-05;경기도 파주시

meningioma

An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge

s/p 20250401resection

- 방사선수술을 포함한 방사선치료 전 상태

열 없음, 열감 없음, 경부 강직 없음, 두통 및 오심 구토 없음,
신경학적 결손 없음, 상처 부위 나쁘지 않음, woozing (-), redness (-)
뇌척수액 비루??????????????

반드시 치료를 요할 정도의 큰 변화는 없는 듯
상태 변화 없음
재발 및 진행 가능함
반드시 추적 관찰 정밀 검사 시행하여야만함
재발 및 진행하면 절제, 방사선수술을포함한 방사선치료
재발 및 진행 가능함
증상 및 징후 잘 보시기
증상 및 징후 나타나면 바로 바로 병원에 오시기
그렇지 않으면 2개월 후 사진

평가(Assessment)

meningioma, brain, cerebral meninges

치료 계획(Plan)

증상 및 징후 나타나면 바로 바로 병원에 오시기
그렇지 않으면 1개월 후 사진 : 안정적이면 그 이후에는 5개월 후
ct
lab
투약 6개월
진단서

2025-05-07 11:23 김정훈 2025-05-07 11:48 김정훈

진료과: 신경외과 진료일자: 2025-06-09

2025-06-09 [신경외과] 외래 나이/성별: 52y/F

▶#

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

외래 경과 기록
(Outpatient Progress Note)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

객관적 소견(Objective)

F/52y; 생년월일:1972-12-05;경기도 파주시

meningioma

An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge

s/p 20250401resection

- 방사선수술을 포함한 방사선치료 전 상태

20250609CT : 반드시 치료를 요할 정도의 큰 변화는 없는 듯
상태 변화 없음
재발 및 진행 가능함
반드시 추적 관찰 정밀 검사 시행하여야만함
재발 및 진행하면 절제, 방사선수술을포함한 방사선치료
재발 및 진행 가능함
증상 및 징후 잘 보시기
증상 및 징후 나타나면 바로 바로 병원에 오시기
그렇지 않으면 5개월 후 사진

평가(Assessment)

meningioma, brain, cerebral meninges

치료 계획(Plan)

증상 및 징후 나타나면 바로 바로 병원에 오시기
그렇지 않으면 5개월 후 사진 : 안정적이면 그 이후에는 5개월 후
mr

2025-06-09 13:13 김정훈

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

퇴원 요약
(Discharge Summary)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

입원과: 신경외과 입원일자: 2025-03-30 입원주치의명: 김정훈 퇴원과: 신경외과 퇴원일자: 2025-04-05 퇴원주치의명: 김정훈
2025-04-05 [신경외과] 입원 #HD : 7 #POD : 4 164병동 나이/성별: 52y/F

입원 사유(Reason for Admission)
headache

진단명
주진단(Principal Diagnosis)
(주) meningioma, brain, cerebral meninges

주요경과 및 수술/시술
수술 및 시술(Operation and Procedure)
[2025-04-01]NS 김정훈 resection, brain tumor
입원 경과(Hospital Course)
==========
#. R/O Sphenoidal ridge meningioma, Lt.
[2025-04-01]NS 김정훈 resection, brain tumor

#. h/o Pleurisy (30YA)
==========

** Brief History >>
'24.07.-- 간헐적 두통 있던분으로 증상 빈도 증가

'24.10.28 F/E 위해 본원 NS OPD 내원.

'24.11.12 시행한 검사상 meningioma 확인됨

'25.03.17 resection OP 고려하기로 함

'25.03.30 수술 위해 입원함

** Hospital course >>
'25.04.01 resection op 시행후 NSICU 입실

'25.04.02 post op MR 시행 // GW 전동

'25.04.04 Lab f/u

'25.04.05 퇴원함

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

퇴원 요약
(Discharge Summary)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

** sphenoid ridge meningioma에 대해 resection 시행하였습니다.

퇴원 시 상태(Condition at Discharge) : 호전됨

퇴원 형태(Type of Discharge) : 정상 퇴원

협의 정보

2025-03-31[NS] → [ANS] sphenoid ridge meningioma, brain, cerebral meninges

추후 관리 계획(Plan)

2025-05-07NS 김정훈 외래진료예약

퇴원약 포함 주요 약물은 의사지시에서 전자인증되었습니다.

퇴원약 포함 주요 약물(Significant Medication Including Discharge Medication)

	처방명	투여량	투여단위	횟수	일수
1	Dexamethasone tab [0.5mg]	4	TAB	1회	1일
2	Gaster tab [20mg]	1	TAB	1회	1일
3	Keppra tab [500mg]	1	TAB	2회	35일
4	Tylenol 8hrs ER tab [650mg]	1	TAB	3회	7일
5	Mago cap [500mg]	1	CAP	3회	7일
6	Naxen F tab [500mg]	1	TAB	2회	7일

2025-04-02 13:52 전예림 2025-04-07 07:50 김정훈

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

수술 기록
(Operative Record)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

진료과: 신경외과 진료일자: 2025-03-30

2025-04-01 [신경외과] 입원 #HD : 3 #POD : 0 신경외과중환자실/09 나이/성별: 52y/F

수술 전

수술 전 진단명(Preoperative Diagnosis)

sphenoid ridge meningioma, brain, cerebral meninges

수술 전 수술명(Preoperative Name)

resection, brain tumor

수술 후

수술 후 진단명(Postoperative Diagnosis)

sphenoid ridge meningioma, brain, cerebral meninges

수술 후 수술명(Postoperative Name)

resection, brain tumor

수술 일자(Date of Operation)	2025/04/01	집도과(Operative Departement)	NS
집도의(Surgeon)	김정훈		
제1 보조의(1st assistant)	변유경	제2 보조의(2nd assistant)	
제3 보조의(3rd assistant)		소독 간호사(Scrub Nurse)	조재은
마취 방법(Method of Anesthesia)	GENERAL	마취 의사(Anesthesiologist)	박용석
마취 시간(Time of Anesthesia)	13:16 ~ 20:09	수술 시간(Time of Operation)	13:46 ~ 19:58
재수술 여부(Reoperation)		배액 유무(Drainage)	
스펀지 수 확인(Sponge Count Verified)		검체(Specimen)	yes
출혈량(Estimated Blood Loss)	10 ~ 100cc		

수술 중 특이 사항(Unexpected Event) ◉ 없음 ○ 있음

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

수술 기록
(Operative Record)

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2******

수술 소견(Operative Finding)

intenal debulking
sylvian vein encroachment
M1 upward deviation
tumor: whitish, firm
Simpson Gr 1 GTR achieved

수술 과정(Operative Procedure)

The patient was placed in the supine decubitus position with the head fixed in a 3 pin headholder with the neck extension and rotated towards the right.

#Head was shaved and was thorouglysteralized and prepared, curvilinear incision starting at the root of the zygomatic arch, Raney clips were placed for hemostasis,a single fasciomyocutaneous flap was created which was then detached from the bone and displaced forward, temporalis muscle was preserved, scalp was reflected anteriorly and fixed to the hook.

#3 burr holes were placed near the pterion, and each on the zygomatic base, temporal, dura separator was used to
carefully strip the dura off the inner table,epidural tack-up stitches were placed, The craniotomy flap was made using the craniotome, the bone flap was elevated and the dura was incised in reverse C shape and lifted up.

Under microscope, lesional internal debulking and removal of the mass was done using suction tip and CUSA. Sylvian veins were carefully protected as well as Lt. M1 branches and the capsule was detached from the temporal base.

#After the macroscopic resection of the tumor was completed, meticulous hemostasis was obtained and a tight dural
closure was achieved with artificial dura and with the use of tacocomb.

#The bone flap was reapproximated and fixed to the skull with titanium plate burr hole covers and the scalp was realigned and the skin was closed.

2025-04-01 20:03 정서미
2025-04-03 09:46 김정훈

2025-04-02 19:06 정서미

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

간호정보조사

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2****** 나이/성별: 52y/F
입원과: 신경외과 입원일자: 20250330 병동/병실: 164/05

기본 정보

입원 일시 : 2025/03/30 14:01
정보 제공자 : 환자
가족력
암 가족력 : 없음
기타 가족력 : 있음 - 모-부정맥

사회적 상태

결혼 여부 : 기혼
직업 : 주부
종교 : 기독교
사용 가능 언어
한국어 : 읽기 가능, 쓰기 가능
문화적 특수성 : 무

입원 정보

입원 경로 : 외래
입원 방법 : 도보
주호소 : 두통
발생 일자 : 2024/01/02
입원 동기
간헐적인 정수리 통증 3-4MA 상기 증상 빈도가 잦아짐
정밀 검사 및 치료위해 본원 내원함

r/o meningioma, left sphenoid ridge
타원 경유력 : 무
해외 경유력 : 무

현재 및 과거력

현재 및 과거력 : 없음
입원력 : 있음 - 30년 전 늑막염치료, 10년 전 부비동염치료
수술 병력 : 있음 - 30년 전 늑막염치료,10년전 부비동염치료

투약력

최근 투약 상태 : 있음

과민 반응 정보

약물 : 없음
조영제 : 없음
수혈 : 확인 불가
약물 / 조영제 / 수혈 외 과민 반응 :없음

임신 정보 : 현재 임신 아님

신체적 상태

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

간호정보조사

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2****** 나이/성별: 52y/F
입원과: 신경외과 입원일자: 20250330 병동/병실: 164/05

활력 징후 : 혈압 120/76mmHg , 맥박 72회/min , 호흡 16회/min , 체온 T 37.1°C
신체 계측 : 체중 64kg, 신장 162cm, 측정
호흡기 문제 : 없음
마비 및 쇠약 : 없음
시력 장애 : 없음
청력 장애 : 없음
피부 상태 : 정상

영양 위험 검색

BMI : 24.4 , 18.5 ≤ BMI
한 달간 의도치 않게 체중이 3kg 이상 감소 : 아니오
일주일간 식사량이 평소의 절반 이하로 감소 아니오
중환자실 입실 : 아니오
=> 영양 상태 평가 결과 :저위험군

의식 및 정서 상태

의식 상태 : alert & oriented
지남력 : 시간 (있음) , 장소 (있음) , 사람 (있음)
의사 소통 : 원만함
정서 상태 : 안정
자살 / 자해 위험성 자가 평가 시행 무

습관

대변
횟수 : 1회 /2일
양상 : 변비
소변
횟수 : 7-8회 /1일
양상 : 정상
수면 상태
수면 시간 : 5-6hr(s)
수면 장애 : 없음
음주 : 무
흡연 : 무

교육 요구도

필요 교육 항목 : 질환 및 치료 교육
선호 교육 방법 : 선호 없음
선호 교육 형태 : 선호 없음

퇴원 계획

퇴원 후 돌봄 제공자 :배우자
퇴원 후 거주 예정지 :타병원

병원 생활 안내 교육

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

간호정보조사

병원등록번호: 69768374 환자성명: 이진희 주민등록번호: 721205-2****** 나이/성별: 52y/F
입원과: 신경외과 입원일자: 20250330 병동/병실: 164/05

피교육자 : 환자 교육자 : 정지수 금연 교육 : Y

보고

보고 의사 : 김경주 보고 시간 : 2025/03/30 14:02 보고자명 : 정지수

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

영상의학과 검사 보고서

병원등록번호 : 69768374	환자성명 : 이진희	생년월일 나이/성별:1972-12-05/51/F	처방일자 :2024-10-28
의뢰과/의뢰의:신경외과/김정훈		진료구분 :외래	검사일자 :2024-10-30
확인의 :	검사번호 : 24-54-103657	최초보고일자 :2024-11-13	최종보고일자 :2024-11-13
시행의 :		판독의 :박상익/박상익	

MR,Brain (with enhance)(3.0T) 20241030:1014 20241030:1100
CT,Head angiography (Tumor)(with enhance) 20241112:1112 20241112:1136
*
Clinical information: 간헐적인 정수리 통증
Compared with previous study: not available.

Technique:
Sagittal T1, axial T2, FLAIR, T1, GRE, enhanced T1, and enhanced 3D T1 images were obtained.
Head CTA was obtained.

Findings:
1. Brain parenchyma -
Minimal leukoaraiosis.
A suspicious tiny nonenhancing lesion on the right side of the pituitary stalk (SE 24 IM 25), R/O nonneoplastic cystic lesion.

2. CSF spaces - WNL.

3. Others -
An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge.

S/P bilateral Caldwell-Luc operation.
R/O postoperative mucocele in the right maxilla.

4. CTA -
Superior displacement of the left MCA and mild luminal narrowing of the left MCA M1 segment by the mass.

5. No definite brain atrophy, hydrocephalus, hemorrhage, or infarction in the cerebral and cerebellar hemispheres, brainstem and extraaxial space.

[결 론]

1. An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge.
2. CTA: Superior displacement of the left MCA and mild luminal narrowing of the left MCA M1 segment by the mass.

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

영상의학과 검사 보고서

병원등록번호 : 69768374	환자성명 : 이진희	생년월일 나이/성별:1972-12-05/52/F	처방일자 :2025-05-07
의뢰과/의뢰의:신경외과/김정훈		진료구분 :외래	검사일자 :2025-06-09
확인의 :	검사번호 : 25-52-214128	최초보고일자 :2025-06-09	최종보고일자 :2025-06-09
시행의 :		판독의 :최충곤/최충곤	

CT,Brain (with enhance) 20250609:1015 20250609:1022

*
Clinical information: Follow up after surgical removal of the meningioma, left sphenoid ridge.
Compared with previous CT: 2025-4-1.

Findings:
Left middle cranial fossa에 surgical defect와 postoperative change가 있으며 previous CT와 비교하여서 pneumocephalus가 감소하였음.
Definite한 intracranial hemorrhage나 residual tumor의 evidence 없음.

[결 론]

Gross total removal of the meningioma and decreased postoperative change, left middle cranial fossa since the previous CT.

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

영상의학과 검사 보고서

병원등록번호 : 69768374	환자성명 : 이진희	생년월일 나이/성별:1972-12-05/52/F	처방일자 :2025-03-31
의뢰과/의뢰의:신경외과/김정훈		진료구분 :입원(164)	검사일자 :2025-03-31
확인의 :김호성	검사번호 : 25-54-030539	최초보고일자 :2025-04-01	최종보고일자 :2025-04-01
시행의 :		판독의 :김호성/김호성	

MR,Brain lab (with enhance)(3.0T) 20250331:2244 20250331:2255

*
An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge.
MR was done for stereotactic localization

[결 론]

An approximately 4-cm probable meningioma along the left sphenoid ridge.
MR was done for stereotactic localization

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

영상의학과 검사 보고서

병원등록번호 : 69768374	환자성명 : 이진희	생년월일 나이/성별:1972-12-05/52/F	처방일자 :2025-04-01
의뢰과/의뢰의:신경외과/김정훈		진료구분 :입원(164)	검사일자 :2025-04-02
확인의 :	검사번호 : 25-54-031031	최초보고일자 :2025-04-30	최종보고일자 :2025-04-30
시행의 :		판독의 :김호성/김호성	

MR,Brain tumor & Diffusion (Extra-axial)(with enhance)(3.0T) 20250402:0648 20250402:0658
CT,Brain (without enhance) 20250401:1901 20250401:1919
*
Clinical information: S/P resection of left sphenoid ridge meningioma.
Compared with 2024-10-30.

Technique:
3D T1WI, thin-slice sagittal/axial/coronal T2WI, axial FLAIR, axial GRE, DWI, and 3D enhanced T1WI images were obtained.

Findings:
Gross total resection of left sphenoid ridge meningioma.
Minimal linear contrast enhancing lesion along the anterior and medial aspect of the op site.
—> DDx. between postop change vs. minimal residual tumor.
Cerebral infarction is noted at the left anterior temporal lobe around the previous op site.
No evidence of other postop unusual finding.

[결 론]

Gross total resection of left sphenoid ridge meningioma.
Minimal linear contrast enhancing lesion along the anterior and medial aspect of the op site.
—> DDx. between postop change vs. minimal residual tumor.
Cerebral infarction is noted at the left anterior temporal lobe around the previous op site.
No evidence of other postop unusual finding.

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

병리 보고서(조직)

(25-S -021898)

병원등록번호	69768374	환자성명	이진희	생년월일 나이/성별	19721205 52/F
처방일자	20250401	진료구분	입원 (164-05)	의뢰과/의뢰의	NS/ 김정훈
검사일자	20250401	최초보고일자	20250407	최종보고일자	20250407
판독의	남수정 / / /			육안검사자	채건호/남수정
자문의				Consulted by	
임상소견					

FA. Brain (brain tumor)
B. Brain (brain tumor)

DIAGNOSIS :
FA&B) Brain, (left sphenoid ridge), resection:
- Meningioma, WHO grade 1,
  with 1) histological type: meningothelial
  2) CNS WHO grade: 1
  3) brain invasion: cannot be assessed
  4) mitotic count: < 1/2 ㎟
  5) increased cellularity: not identified
  6) small cells with a high N/C ratio: not identified
  7) prominent nucleoli: not identified
  8) sheet-like growth pattern: not identified
  9) spontaneous necrosis: not identified
  10) KI-67 labeling index: 5.4 %

NOTE:
Please refer to the result(s) of the immunohistochemical/histochemical staining below.

*PHH3 : mitotic count: <1 /2 ㎟
*KI-67 : Automatic quantification <See the attached PDF file>
B1 (Lesion 1) : 5.4% (351/6478), 5% by eyeballing

GROSS :
FA.
1. Specimen: Brain (brain tumor), x 1,
2. Slide key: Totally embedded in one block(s)
FDx.: (Brain (brain tumor)):
1. Meningioma
(조의리/송하림)

B.
1. Specimen status: Formalin fixed

이 문서는 서울아산병원의 문서입니다. 동의없이 수정, 변경 및 복사할 수 없습니다.

병리 보고서(조직)

(25-S -021898)

병원등록번호	69768374	환자성명	이진희	생년월일 나이/성별	19721205 52/F
처방일자	20250401	진료구분	입원 (164-05)	의뢰과/의뢰의	NS/ 김정훈
검사일자	20250401	최초보고일자	20250407	최종보고일자	20250407
판독의	남수정 / / /			육안검사자	채건호/남수정
자문의				Consulted by	
임상소견					

2. Procedure: Resection
3. Specimen: Labeled "brain tumor"
A fragment of grayish white soft tissue (3.5 x 1.5 x 1 cm)
4. Slide keys: 2 cassettes (multisected and entire)
(ghc/lee)